مسودة: قيد المراجعة السريرية

قياس السكر في المنزل

كيف تقيس، وكيف تسجّل، ومتى تطلب المساعدة، مع سجل تُحضره في كل زيارة

خمس نقاط تذكّرها

- **اغسل يديك وجفّفهما** قبل كل قياس.
- سجّل **كل** قراءة مع الوقت، وهل كانت قبل الأكل أم بعده.
- **أقل من 70**: خذ 15 غرامًا من سكر سريع، ثم أعد القياس بعد 15 دقيقة.
- عند المرض: قِس **كل 4 ساعات**، واستمر في الشرب، و**لا توقف الإنسولين أبدًا**.
- أحضر هذا السجل وجهازك وأدويتك في **كل زيارة**.

متى أقيس؟

علاجي	القياس المعتاد (قد يغيّره طبيبك)
إنسولين مع الوجبات (عدة حقن في اليوم)	قبل الوجبات وعند النوم، وأحيانًا بعد الوجبات بساعتين.
إنسولين طويل المفعول مرة يوميًا، أو جليكلازايد أو جليميبرايد	قبل الإفطار كل يوم، وكلما شعرت بهبوط أو تعب.
حبوب أخرى أو حقن أسبوعية فقط	حسب نصيحة طبيبك، وغالبًا بضع مرات في الأسبوع.
أي علاج	عند الرجفة أو التعرّق أو التشوّش، وأكثر عند المرض أو الصيام (انظر نشرة رمضان)، وقبل القيادة لمن يستخدم الإنسولين أو جليكلازايد أو جليميبرايد.

كيف أقيس؟

- اغسل يديك بالماء والصابون وجفّفهما جيدًا؛ فالسكر على الأصابع يعطي قراءة مرتفعة غير صحيحة.
- استخدم جانب طرف الإصبع، وغيّر الإصبع في كل مرة.
- استخدم شرائط صالحة، وإبرة وخز جديدة في كل مرة لا تشاركها أحدًا، وضع الإبر المستعملة في علبة بلاستيكية صلبة.
- إذا كنت تستخدم حسّاسًا (قياس مستمر)، فأحضر تقرير التطبيق، واحتفظ بجهاز الوخز للتأكد عندما لا تتوافق القراءة مع ما تشعر به.

ما أهدافي؟

متى؟	الهدف المعتاد لكثير من البالغين	هدفي (يحدده طبيبي)
قبل الوجبات	80 إلى 130 ملغ/دسل (4.4 إلى 7.2 ملمول/لتر)	
بعد بدء الوجبة بساعة إلى ساعتين	أقل من 180 ملغ/دسل (10.0 ملمول/لتر)	

كبار السن ومن يتعرّضون للهبوط تكون أهدافهم غالبًا أعلى.

هبوط السكر: أقل من 70 ملغ/دسل

- العلامات: رجفة، تعرّق، جوع، تسارع في ضربات القلب، تشوّش. وبعض الناس لا يشعرون بشيء، فقِس إذا لم تكن متأكدًا.
- خذ **15 غرامًا من سكر سريع**: 3 ملاعق صغيرة من السكر مذابة في الماء، أو نصف كوب (120 مل) من العصير العادي، أو أقراص الجلوكوز، واحملها معك دائمًا.
- أعد القياس بعد **15 دقيقة**، وإذا بقي أقل من 70 فكرّر. وعندما يرتفع فوق 70، تناول وجبة خفيفة أو وجبتك.
- سجّل كل هبوط في الصفحة 4، وأخبر طبيبك.

أيام المرض

- قِس السكر **كل 4 ساعات** ليلًا ونهارًا.
- اشرب كوبًا من الماء أو مشروبًا خاليًا من السكر كل ساعة.
- **لا توقف الإنسولين أبدًا**؛ فقد تحتاج إلى جرعة أكبر.
- بعض الحبوب قد تحتاج إلى إيقاف مؤقت ما دمت لا تستطيع الأكل أو الشرب، مثل ميتفورمين وداباغليفلوزين وإمباغليفلوزين وبعض أدوية الضغط ومدرّات البول. لا تفعل ذلك إلا إذا أعطاك طبيبك خطة لأيام المرض.
- السكري من النوع الأول، أو السكر أعلى من 300: افحص الكيتونات إذا كانت لديك شرائطها.

فورًا **اتصل بـ 997 أو اذهب إلى الطوارئ**

- هبوط لا يتحسن بعد علاجه مرتين، أو أصبح الشخص مشوّشًا أو نعسانًا جدًا أو يتشنّج. لا تعطِ طعامًا أو شرابًا لمن لا يستطيع البلع.
- قيء مع عدم القدرة على شرب السوائل.
- سكر أعلى من 300 مع ألم في البطن أو قيء أو تنفّس سريع وعميق أو نعاس، أو كيتونات متوسطة أو عالية.
- إذا كنت تأخذ داباغليفلوزين أو إمباغليفلوزين وأصابك قيء أو ألم في البطن أو تنفّس سريع، **حتى لو كان السكر طبيعيًا**.

اليوم **تواصل مع عيادتك اليوم (أو اتصل بـ 937)**

- بقي السكر أعلى من 250، أو بقيت قراءات ما قبل الأكل أعلى من 240 أكثر من يوم.
- حمّى أو مرض لمدة يومين، أو قيء أو إسهال لأكثر من 6 ساعات.
- هبوط أقل من 54، أو هبوط احتجت فيه إلى مساعدة غيرك، أو هبوطان أو أكثر في الأسبوع.

الزيارة القادمة **أحضره في زيارتك القادمة**

- معظم القراءات أعلى من هدفك.
- أسئلة عن أدويتك أو طعامك أو نشاطك، أو هل يناسبك جهاز قياس مستمر (حسّاس).

AA
إعداد وإشراف طبي: د. البراء البواب، طب الأسرة
المؤسس والمحرر الطبي، أدلة طب الأسرة

تقدّم هذه النشرة معلومات عامة، ولا تغني عن نصيحة طبيبك الذي يعرف حالتك. أحضرها معك في زيارتك القادمة واسأل عن أي شيء غير واضح. صيغت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وراجعها المحرر الطبي، وما زالت قيد المراجعة مع الزملاء.

آخر تحديث: أكتوبر 2026 · **المراجعة القادمة:** أكتوبر 2027، أو قبل ذلك إذا تغيّرت التوصيات

المصادر:

1. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes-2026, Sections 6 (glycemic goals, hypoglycemia, hyperglycemic crises, intercurrent illness) and 7 (diabetes technology). Diabetes Care 2026;49(Suppl 1); Summary of Revisions doi:10.2337/dc26-SREV
2. Saudi Ministry of Health. Diabetes and being sick: health awareness (moh.gov.sa)
3. Joint British Diabetes Societies. Sick day rules and SGLT2 inhibitor patient guidance (2025)
4. IDF-DAR Practical Guidelines: Diabetes and Ramadan, 2021; 2026 risk calculator update

سجل السكر

أحضره في كل زيارة

الاسم: _____ رقم الملف: _____

نوع السكري: _____ جهاز القياس: _____

أدويتي وجرعات الإنسولين: _____

أهدافي (يكتبها الطبيب): _____

اكتب القراءات بوحدة ملغ/دسل. **ضع دائرة** حول أي قراءة أقل من 70. واكتب جرعات الإنسولين أو تغييراتها في الملاحظات.

التاريخ	قبل الإفطار	بعد الإفطار	قبل الغداء	بعد الغداء	قبل العشاء	بعد العشاء	عند النوم	ملاحظات / إنسولين
15/10	118				142		126	غداء خارج المنزل

للعيادة

القراءات أقل من 70 / أقل من 54: ____ متوسط ما قبل الإفطار: _____ راجعه / التاريخ: _____

الهبوط وأيام المرض

أحضره في كل زيارة

سجل هبوط السكر (أقل من 70)

التاريخ والوقت	القراءة	ماذا حدث / بماذا شعرت	ماذا أخذت	القراءة بعد 15 دقيقة	احتجت مساعدة؟ (نعم / لا)

سجل أيام المرض

التاريخ والوقت	السكر	الكيتونات	ما شربته في آخر 4 ساعات	الأدوية والإنسولين	ملاحظات

أسئلة لزيارتي القادمة